SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO PONTEVEDRA

COMTA: Compartir Talento

COMTA: Compartir Talento

Versión 1.0. Fecha: 05/07/2023

Promotor:
Juan Turnes Vázquez
Investigador principal:
Juan Turnes Vázquez, Investigador Responsable del Grupo de Hepatología y Enfermedades Inflamatorias Intestinales del IIS Galicia Sur y Jefe de Servicio de Digestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Investigadores/as colaboradores:
Santiago Pérez Cachafeiro [(1)(2)], Modesto Martínez Pillado[(2)(3)], María Coro Sánchez Fernández[(1)], Indhira Miosotis Pérez Medrano[(3)], Pablo Parada Vázquez [(3)], Marta Castro González [(4)], Ana Enériz Janeiro [(4)]

[1] Centro de Salud Virgen Peregrina de Pontevedra
[2] Instituto de Investigación Biomédica Galicia Sur
[3] Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra
[4] Departamento de Investigación del Servicio de Digestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Índice

Resumen **3**

Antecedentes y justificación del proyecto **4**

Hipótesis del estudio **6**

Objetivos **6**

Tipo de estudio **6**

Material y métodos **7**

Ámbito de estudio 7

Definición de los sujetos a estudio 7

Selección y retirada de sujetos: 7

Captación y reclutamiento de los participantes 8

Justificación del tamaño muestral 8

Variables principal y secundarias 8

Descripción de la intervención 9

Cronograma y fecha prevista de finalización. 10

Plan de análisis estadístico 10

Aspectos ético-legales **11**

Modelos de consentimiento informado: hoja de información a participantes y hoj de consentimiento informado 12

Compromiso de publicación de los resultados 16

Memoria económica y fuente de financiación **16**

Bibliografía **17**

ANEXOS **18**

ANEXO 1: Cuestionario 18

Resumen

- **Título del proyecto:** “COMTA: Compartir Talento”
- **Código protocolo:** COMTCT
- **Versión de protocolo con fecha:** Versión 1.0. Fecha: 05/07/2023.
- **Promotor/a:** Juan Turnes Vázquez
- **Investigador/a principal:** Juan Turnes Vázquez
- **Investigadores/as colaboradores:** Santiago Pérez Cachafeiro, Modesto Martínez Pillado , María Coro Sánchez Fernández, Indhira Miosotis Pérez Medrano, Pablo Parada Vázquez, Marta Castro González, Ana Enériz Janeiro
- **Centros en los que se va a realizar el estudio:** Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Centro de Saúde Virxe Peregrina de Pontevedra, Centro de Saúde de Lérez, Centro de Saúde de A Parda
- **Diseño del estudio:**

Estudio antes y después de la implementación del sistema de apoyo a la toma de decisiones COMTA. Se realizará una evaluación cada 6 meses mediante cortes transversales.

- **Condición a estudio**: Coordinación y comunicación entre niveles asistenciales
- **Objetivo principal y secundarios:**

Se presenta en este protocolo el estudio de evaluación del proyecto COMTA. Este proyecto consiste en la puesta en marcha de un sistema de ayuda a la toma de decisiones basado en tecnología innovadora para lo que se propone un estudio ex-ante y ex-post así como una evaluación cada 6 meses. A continuación se presentan los objetivos de la evaluación

  - **Principal:**

Evaluar el impacto de un sistema de apoyo a la toma de decisiones médicas en la coordinación y colaboración entre diferentes niveles asistenciales

  - **Secundarios**
    - Describir las necesidades y demandas de los profesionales en torno a la coordinación y sinergias conjuntas
    - Estimar el impacto de utilizar nuevos mecanismos y estrategias de comunicación y coordinación entre niveles asistenciales
    - Evaluar el conocimiento y actitud de los profesionales a mecanismos digitales

- **Variable principal de valoración:**
  Grado de adopción y utilización del sistema de apoyo a la toma de decisiones por parte de los médicos de Atención Primaria

- **Población en estudio y número total de sujetos:**

Médicos de Atención Primaria de los tres centros de salud seleccionados (Centro de Saúde Virxe Peregrina de Pontevedra, Centro de Saúde de Lérez, Centro de Saúde de A Parda), que cuentan con un total de 46 facultativos. De todos ellos, se estima que participe en el proyecto un 50%, por lo que se realizará este estudio tomando a todos los participantes.

Antecedentes y justificación del proyecto

Como sostienen Mitchell et al. (2008), cuando los especialistas y el médico de Atención Primaria colaboran en la atención al paciente, se consiguen resultados complementarios, además de una posible reducción de costes y mejoras en la satisfacción del paciente con el servicio, así como en la práctica clínica de los médicos de Atención Primaria.

Las iniciativas similares existentes hasta el momento difieren del proyecto COMTA en varios aspectos. La atención o talento compartido se define en términos de digitalización del sistema, recurriendo al desarrollo tecnológico para mejorar equipos o para el uso de métodos de comunicación digitales frente a los tradicionales. La mayoría de las iniciativas que se pueden considerar como referentes incluyen la innovación tecnológica en forma de aplicación. Estas aplicaciones incorporan una serie de algoritmos en forma de árbol de decisiones, pero cuentan con limitaciones al ofrecer alternativas dicotómicas que excluyen los matices y las ambigüedades y no consiguen tener en cuenta todas las opciones. Además, las aplicaciones no siempre están disponibles para los ordenadores personales de los médicos por lo que se hace necesario dotar a cada uno de los profesionales, de smartphones (Urruticoechea-Arana, et al 2020).

Son escasas las acciones que promuevan la interacción presencial entre profesionales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria con medios digitales innovadores, más allá de intentos por fomentar la implementación de las TIC y las teleconsultas. De hecho, un 42% de los estados miembros de la OMS respondieron que no tenían estrategias en e-Salud. Por otra parte, algunos estudios muestran que los programas de consultas telefónicas entre especialistas médicos facilitan la atención del paciente y pueden evitar “descompensaciones agudas” (Tian, Harris et al 2021).

Los primeros estudios del uso de modelos de lenguaje en el campo de la salud resaltan la importancia de seguir investigando esta tecnología en entornos clínicos. Un estudio (Ayers et al, 2023) ha comparado las respuestas proporcionadas por médicos con las generadas por un chatbot avanzado en respuesta a preguntas publicadas en un foro público en línea. Los resultados revelan una preferencia mayor por las respuestas del chatbot debido a su alta calidad y capacidad para empatizar. Estos hallazgos tienen un impacto positivo en los objetivos que buscamos alcanzar con COMTA, una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que cuenta con información de calidad rigurosamente verificada por nuestro equipo de profesionales.

En la línea de fomentar la colaboración entre diferentes niveles asistenciales destaca el sistema RAAPID (Referral, Access, Advice, Placement, Information, and Destination) implantado en Alberta, Canadá. Con este sistema los médicos tienen acceso a consultas telefónicas con especialistas 24 horas garantizando un asesoramiento rápido a los servicios de atención provinciales de Alberta.

También actúa coordinando el traslado de pacientes a los centros adecuados y la gestión de las camas. Si bien hay sistemas de atención similares, este cuenta con una ventaja que viene dada por las relaciones establecidas entre los médicos y los grupos operacionales que hacen a la herramienta confiable asegurando la calidad y seguridad del servicio (E RAAPID). Este es uno de los aspectos que COMTA tomará como referencia, pero dando un paso más allá, incorporando información verificada por especialistas y profesionales con amplia experiencia en patologías digestivas. COMTA difiere también de RAAPID y otras iniciativas en que pone el foco en la comunicación eficiente entre profesionales y no en la gestión de traslados y camas, necesidad ya cubierta en nuestro sistema sanitario.

Un estudio cualitativo llevado a cabo en España en 2018 (Cernadas et al, 2020), ha analizado las opiniones de los facultativos y usuarios sobre los avances en e-Salud. Los médicos de Atención Primaria sostienen que la innovación ha posibilitado una mayor seguridad y mejores diagnósticos. Del mismo modo, advierten sobre algunas irregularidades como la insuficiencia de infraestructura tecnológica adecuada, la falta de formación en el uso de ciertas aplicaciones y "comunicación insuficiente de las funcionalidades disponibles" lo que provoca un uso de *software* por debajo de sus posibilidades. Uno de los facultativos participantes en el estudio, médico de Atención Primaria del SERGAS, demanda:

> "Mayor soporte a la decisión. Es decir, que si yo estoy viendo a un paciente diabético, lo primero que me aparezca, porque ya tenga ese diagnóstico, lo primero que yo tenga en la pantalla sea su última glucemia, su última hemoglobina y tal […], o por el hecho de que voy prescribir una insulina ya me aparezca directamente todo este tipo de informaciones. Toda esa inteligencia que requiere un gran volumen de explotación por debajo es, yo creo, que es otra de las grandes perspectivas que ofrece esto para el futuro, ¿no?". p. 397

En relación con nuestro proyecto, estos facultativos exponen que los problemas de *software* son un obstáculo porque los médicos de Atención Primaria no siempre tienen acceso a informes o datos para realizar estudios epidemiológicos. Proponen seguir avanzando en "sistemas que faciliten su trabajo, más coherentes y con funcionalidades" (*Cernadas et al, 2020*). COMTA se ajusta a estas demandas: es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, tiene como objetivo generar conocimiento compartido entre profesionales de Atención Hospitalaria (AH) y Atención Primaria (AP) fomentando su comunicación y ofreciendo formación sobre la herramienta a los médicos de ambas partes. La evaluación continua del proyecto permitirá adecuarnos a las necesidades que puedan surgir de forma que si es necesario, se pueden realizar diferentes talleres de formación que permitan una mejor adaptación y usabilidad de la herramienta.
Teniendo en consideración los avances hasta el momento, el público estratégico formado por los profesionales de AP y AH es fundamental. Su actuación es determinante para la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que permitirán que el sistema siga avanzando de acuerdo a los nuevos retos de innovación.

El proyecto COMTA está plenamente alineado con la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud. Como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud Digital es un

acelerador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Secretaría General de Información e Innovación para el SNS, 2021). El proyecto que nos ocupa también está en sintonía con el Plan España Digital 2025, en el que se alude a la formación y capacitación digital especializada para los y las profesionales del sector sanitario, (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2020).

Por otra parte, también está en línea con lo propuesto en la Estrategia Global de Salud Digital de la OMS, que alude a, "utilizar de forma eficaz las tecnologías digitales centradas en las personas para facilitar al personal sanitario la toma de decisiones basadas en la evidencia y reforzar la rendición de cuentas de los sistemas de salud" (Organización Mundial de la Salud, 2020, p.68).

Hipótesis del estudio

Poner a disposición de los médicos de Atención Primaria un sistema de apoyo a la toma de decisiones basado en contenidos avalados científicamente por profesionales del Servicio de Digestivo mejora la coordinación entre niveles asistenciales y la seguridad de los pacientes. La decisión asistencial sigue siendo del facultativo, sólo se proporciona un sistema de apoyo complementario a otros actualmente disponibles como Clinical Key® o Guía Terapeútica®

Objetivos

- **Objetivo principal:**
  - Evaluar el impacto de un sistema de apoyo a la toma de decisiones médicas en la coordinación y colaboración entre diferentes niveles asistenciales
- **Objetivo: Secundarios**
  - Describir las necesidades y demandas de los profesionales en torno a la coordinación y sinergias conjuntas
  - Estimar el impacto de utilizar nuevos mecanismos y estrategias de comunicación y coordinación entre niveles asistenciales
  - Evaluar el conocimiento y actitud de los profesionales a mecanismos digitales

Tipo de estudio

Se trata de un estudio antes y después con una evaluación cada 6 meses mediante cortes transversales en el que se obtendrá la información a través de técnicas cualitativas y cuantitativas. Por una parte, se recoge información a través de encuestas realizadas a profesionales de AP y AH en tres puntos diferenciados: previamente a la implementación del sistema, a los 6 meses del comienzo del proyecto y una vez terminado el mismo. También se consultarán datos procedentes de

indicadores proporcionados por el propio sistema y se analizarán diferentes indicadores procedentes de fuentes disponibles.

Para completar la información recogida mediante las encuestas se realizarán grupos focales entre los diferentes participantes de ambos niveles asistenciales. El guión de la entrevista aparece en el ANEXO I.

Material y métodos

Ámbito de estudio

El estudio se llevará a cabo en tres de los cinco centros de salud de la ciudad de Pontevedra: Centro de Saúde Virxe Peregrina de Pontevedra, Centro de Saúde de Lérez, Centro de Saúde de A Parda. Estos centros de salud dan cobertura a unas 77,298 tarjetas sanitarias aproximadamente, un número reseñable, teniendo en cuenta que la población del municipio de Pontevedra es de unas 82.828 personas (INE, 2022).

Definición de los sujetos a estudio

Médicos de Atención Primaria trabajadores de los tres centros de salud participantes (Centro de Saúde Virxe Peregrina de Pontevedra, Centro de Saúde de Lérez, Centro de Saúde de A Parda). En los tres centros citados existe un total de 46 médicos, de los cuales se espera que participe aproximadamente un 50% de los mismos.

La distribución de médicos por cada centro de salud se especifica en la siguiente tabla:

CENTRO DE SALUD	TOTAL MÉDICOS AP
Centro de Saúde Virxe Peregrina	24
Centro de Saúde A Parda	15
Centro de Saúde de Lérez	7
TOTAL	46

Elaboración propia a partir de datos internos

Selección y retirada de sujetos:

Se trata de una muestra no probabilística cuya elección depende de los siguientes criterios determinados por las características de la investigación:

- **Criterios de inclusión:**
    - Ser médico de Atención Primaria de alguno de los tres centros de salud

- Acceder a participar en COMTA
- Firmar hoja de consentimiento informado

- **Criterios de exclusión:**
  - Trabajar en otro centro de salud
  - Que no se firme el consentimiento de participación en el estudio.

Captación y reclutamiento de los participantes

Se presentará el proyecto COMTA de forma presencial en una sesión de centro en los diferentes centros de salud mencionados a modo de invitación a participar en el proyecto. Mediante un e-mail de invitación e información a participar se presentará el proyecto y se buscará de forma presencial de la implicación de los diversos profesionales
Una vez acepten participar en el proyecto se les proporcionará la hoja de consentimiento informado en la que se recogen todos los aspectos ético-legales sobre el tratamiento de sus datos personales y la información recogida mediante las encuestas y grupos focales. Una vez firmado el consentimiento (ANEXO) se convierten en nuestros participantes.

Justificación del tamaño muestral

Se trata de una muestra no probabilística o dirigida ya que no busca la representatividad de una población sino que se trata de una muestra formada por todos los médicos de Atención Primaria que accedan a participar en el estudio, es decir, la elección de la muestra depende de las propias características de la investigación. Se trata de una muestra homogénea porque las personas que se van a seleccionar pertenecen a un mismo perfil profesional.
Teniendo en cuenta que el tamaño de la muestra viene determinado por las propias características de la investigación, y que el número total de médicos presentes en los centros de salud es de 46, se estima que participarán en el estudio alrededor de 25 médicos de Atención Primaria, muestra susceptible de aumentar a lo largo de la implementación del mismo.

Variables principal y secundarias

Principal:

Grado de adopción y utilización del sistema de apoyo a la toma de decisiones por parte de los médicos de Atención Primaria (se entiende como adoptado la respuesta muchas veces o algunas veces a la pregunta "¿Con qué frecuencia utiliza el nuevo sistema COMTA?" del cuestionario del Anexo I)

Secundarias:

A continuación se presentan las variables secundarias del estudio

- Variables demográficas (cuantitativa):

    - Sexo (Hombre/Mujer)
    - Edad (Grupo de edad)
- Pertinencia (cuantitativa):
    - Número de profesionales interesados en participar en el proyecto
    - Porcentaje de profesionales que consideran adecuado y conveniente establecer sistema de apoyo a la toma de decisiones
- Impacto (cuantitativa):
    - Variación de indicadores de asistencia: % de interconsultas, % teleconsultas, % de pruebas solicitadas por médicos de Atención Primaria, % de rechazo de interconsultas, % de interconsultas resueltas como e-consultas.
    - Frecuencia con la que los profesionales acuden al sistema de apoyo a la toma de decisiones (número de logins por usuario)
- Satisfacción del usuario (cualitativa):
    - Coordinación y comunicación entre los diferentes niveles asistenciales: percepción de los usuarios a través de una encuesta y grupo focal
- Barreras y desafíos (cualitativa):
    - Ventajas e inconvenientes del uso de la herramienta: percepción de los usuarios a través de encuesta y grupo focal

Descripción de la intervención

Para el análisis de los indicadores de impacto (variación de indicadores asistenciales) se solicitará la extracción de datos al Servicio de Admisión y Documentación Clínica una base de datos del Servicio de Digestivo anonimizada y sin identificador de pacientes en la que se recojan los siguientes datos desagregados por sexo y grupo de edad y cupo asistencial; excluyendo aquellas solicitudes realizadas desde urgencias:

-Frecuencia de cada tipo de consulta/prueba por cupo de Atención Primaria
-Frecuencia de consulta rechazada por cupo de Atención Primaria
-Frecuencia de motivo de rechazo por cupo de Atención Primaria (codificación propia Servicio de Admisión: no cumple protocolo, resuelta por otros medios, ya atendido en hospital, cargado por error, excluido por orden facultativa, eliminado por solicitud del paciente, consulta duplicada)

La recogida de información a través de encuesta se realizará a través de un cuestionario (ANEXO) que se presentará a los participantes después de haber aceptado participar y de haber firmado el consentimiento informado (ANEXO). Se cubrirá en formato físico (papel y bolígrafo) garantizando su anonimidad. Después se procederá a la codificación de los resultados para su posterior análisis.

El grupo focal tendrá lugar en un espacio habilitado para reuniones una vez firmado el consentimiento informado. Se recogerá la información de la sesión del grupo focal con una grabadora (la grabación se realizará bajo previo consentimiento también especificado en el apartado de modelos de consentimiento).

Estos datos se recogerán de forma transversal cada 6 meses, es decir en 3 momentos: previamente a la implementación del sistema de apoyo a la toma de decisiones, 6 meses después de su puesta en marcha y una vez implementado y finalizado el proyecto.

También se desarrollará un grupo de control con aquellos cupos de pacientes que no tienen médico asignado cuyas consultas no se podrá acceder uso del sistema de apoyo a la toma de decisiones (COMTA) . El Servicio de Admisión tratará los datos antes de entregarlos de forma que los cupos no participantes en el proyecto se presentarán agregados como un único cupo para mantener la confidencialidad y poder usar esos datos como control en las comparaciones.

Cronograma y fecha prevista de finalización.

La evaluación se iniciará en septiembre de 2023 y finalizará en agosto de 2024

Proyecto	Fases de la evaluación	Meses												Personas implicadas
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
COMTA	Evaluación de situación inicial de coordinación entre profesionales													Técnico/a de evaluación de proyectos y Dpto. de Comunicación e Innovación de Digestivo
	Evaluación continua del proyecto y toma de acciones correctivas del mismo													Técnico/a de evaluación de proyectos y Dpto. de Comunicación e Innovación de Digestivo
	Evaluación final													Técnico/a de evaluación de proyectos y Dpto. de Comunicación e Innovación de Digestivo

Plan de análisis estadístico

Análisis descriptivo: Se presentarán los resultados en forma de medias (o medianas y rangos intercuartílicos en caso de no cumplir normalidad) y porcentajes. Se realizarán comparaciones mediante diferencias de medias (t-Student) y proporciones (chi-cuadrado) dividiendo los resultados

entre CNPs que participan, CNPs que no participan. Y entre los que participan se analizarán dos grupos en función del grado de utilización (muchas/algunas veces frente a pocas/ninguna).

Se realizará un análisis de forma y fondo mediante el programa Atlas.ti para la información recogida a través de los grupos focales.

Aspectos ético-legales

Durante esta evaluación no se utilizarán datos de pacientes y no se accederá en ningún momento a ninguna historia clínica. Los únicos datos que serán utilizados serán los de los profesionales, que serán previamente informados sobre este estudio y que firmarán un consentimiento. Se utilizarán además datos procedentes de fuentes secundarias disponibles en el sistema (número de interconsultas, derivaciones…)

El equipo investigador cumplirá con las Normas de Buena Práctica Clínica, la Declaración de Helsinki, el Convenio de Oviedo y la normativa vigente de protección de datos y manejo/acceso a la historia clínica.

Los datos del investigador y del estudio serán introducidos y tratados conforme a lo que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), las cuales establecen previsiones encaminadas a garantizar el adecuado desarrollo de la investigación biomédica, teniendo en consideración los beneficios que esta brinda a la sociedad al tiempo que se garantizan el derecho fundamental a la protección de datos.

Cada profesional e investigador que acceda al sistema de apoyo a la toma de decisiones dispondrá de un código de usuario y de una contraseña, ambos confidenciales, intransferibles y sometidos a la Ley de Protección de Datos. Es responsabilidad de ambos mantener la confidencialidad de sus claves y contraseñas y no revelarlas a terceras personas. De igual manera, es responsabilidad de los participantes e investigadores hacer un uso correcto del sistema de apoyo a la toma de decisiones, para lo que, previamente, se hará un trabajo de formación y concienciación. Los datos obtenidos a través de las encuestas a profesionales serán debidamente anonimizados.

No se recogen muestras biológicas. Las intervenciones no requieren póliza de seguro al no ser un estudio experimental.

Los resultados se publicarán en revistas especializadas con alto valor de impacto.

Modelos de consentimiento informado: hoja de información a participantes y hoj de consentimiento informado

HOJA DE INFORMACIÓN A LOS PARTICIPANTES

TÍTULO: COMTA
INVESTIGADOR: Dr. Juan Turnes Vázquez

El objetivo de este documento es brindar información sobre un estudio de investigación en el que está invitado a participar. Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación de Ourense, Vigo, Pontevedra y O Salnés.
Si decide participar en el mismo debe recibir información personalizada por parte del investigador, primero lea este documento y haga todas las preguntas necesarias para entender los detalles al respecto.
La participación en este estudio es completamente voluntaria. Puede decidir no participar o, si acepta hacerlo, cambiar de opinión retirando el consentimiento en cualquier momento sin obligación de dar explicaciones.

¿Cuál es el propósito del estudio?
El objetivo de este estudio es evaluar un sistema de apoyo a la toma de decisiones para mejorar la coordinación entre diferentes niveles asistenciales en busca de ofrecer una mejora en la atención de los pacientes.

¿Por qué me ofrecen participar?
Está invitado a participar porque es un médico de Atención Primaria que pertenece a uno de los centros de salud participantes en este estudio (Centro de Saúde Virxe Peregrina de Pontevedra, Centro de Saúde de Lérez, Centro de Saúde de A Parda)

¿En qué consiste mi participación?
La participación consistirá en la posibilidad de acceder a un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Para evaluar el mismo se le invita a cumplimentar un cuestionario sobre el uso del sistema y la satisfacción con el mismo cada 6 meses y se le invita a participar en un grupo focal con otros médicos de Atención Primaria para recoger su perspectiva de forma cualitativa en relación con el sistema COMTA. Igualmente accede a la extracción semestral de datos numéricos relativos a las derivaciones y teleconsultas realizadas por Vd. a través del gestor de peticiones al servicio de Digestivo. Estos datos se analizarán de manera conjunta para la comparación con los de los otros médicos del área, los resultados se presentarán de manera que no se permita la identificación individual de ningún facultativo.

¿Qué inconvenientes o molestias tiene?
Su participación no implica mayor inconveniente que el tiempo dedicado a la entrevista

¿Obtendré algún beneficio por participar?

No se espera que Ud. obtenga ganancias directas por participar en el estudio. La investigación pretende evaluar un sistema de apoyo a la toma de decisiones para mejorar la coordinación entre diferentes niveles asistenciales.

¿Recibiré información del estudio?
Si usted lo desea, se le facilitará un resumen de los resultados del estudio.

¿Se publicarán los resultados de este estudio?
Los resultados de este estudio serán enviados a publicaciones científicas para su difusión, pero no se transmitirán datos que puedan conducir a la identificación de los participantes.

Información sobre sus datos:
La recogida, tratamiento, conservación, comunicación y transferencia de sus datos se realizará de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016-679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016), la normativa española sobre protección de datos vigente de carácter personal, Ley 14/2007 de investigación biomédica y RD 1716/2011.
La institución en la que se realiza esta investigación es el responsable del tratamiento de sus datos, pudiendo contactar con el Delegado de Protección de Datos del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur a través de los siguientes medios: dirección de correo electrónico: dpo@iisgaliciasur.es/ Tel. .: 986 217 471
Los datos necesarios para la realización de este estudio serán recabados y almacenados de la siguiente forma:

- Seudonimizados (Codificados), la seudonimización es el tratamiento de datos personales de tal forma que no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional. En este estudio solo el equipo de investigación conocerá el código que le permitirá conocer su identidad.

La normativa que regula el tratamiento de datos personales le otorga el derecho a acceder a sus datos, oponerse, rectificar, cancelar, limitar su tratamiento, restringir o solicitar la supresión de sus datos. También puede solicitar una copia de los mismos o que ésta sea enviada a un tercero (derecho de portabilidad).

Para ejercer estos derechos puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos del centro a través de los medios de contacto indicados anteriormente o al investigador principal de este estudio en la dirección de correo electrónico: juan.turnes.vazquez@sergas.es Telf..: 986 800 513

Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando considere que no se ha respetado alguno de sus derechos. Únicamente el equipo de investigación y las autoridades sanitarias, que tienen el deber de confidencialidad, tendrán acceso a todos los datos recogidos en el estudio. La información que no puede ser identificada puede ser transmitida a terceros. En caso de que se transmita alguna información a otros países, se realizará con un nivel de protección de datos equivalente, al menos, al exigido por la normativa española y europea.

Al finalizar el estudio, o el plazo legal establecido, los datos recopilados serán eliminados o guardados de forma anónima para su uso en futuras investigaciones según lo que Ud. elegir en la hoja de firma de consentimiento.

¿Hay intereses financieros en este estudio?

Usted no será remunerado por participar. Se trata de un estudio independiente para el que se ha obtenido financiación parcial de AbbVie y Novo Nordisk. Es posible que de los resultados del estudio se deriven productos comerciales o patentes; en este caso, Vd. no participará de los beneficios económicos generados.

¿Cómo contactar con el equipo de investigación de este estudio?

Verás puede contactar con el equipo de investigación en el teléfono 986800907 y/o en la dirección de correo electrónico pontegastro@gmail.com

Muchas gracias por su cooperación.

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO:

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO/ASENTIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO:____ COMTA: Compartir Talento. _____

Yo, _____

1. He leído la hoja de información a los participantes del estudio que se me entregó y he podido conversar con _____ y hacer todas las preguntas necesarias sobre el estudio.
2. Comprendo que mi participación es voluntaria, y que puedo retirarme del estudio cuando quiera
3. Accedo a que se utilicen mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información al participante.
4. Presto libremente mi conformidad para participar en este estudio.

Al terminar el estudio, mis DATOS acepto que sean:

Eliminados

Conservados anonimizados para usos futuros en otras investigaciones.

Firmado.: El participante, Firmado.: El/la investigador/a que solicita el consentimiento

Nombre y apellidos:_____ Nombre y apellidos:_____

Fecha: Fecha:

Compromiso de publicación de los resultados

Los resultados parciales buscarán ser presentados en el Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD). Además, se buscará presentar dichos resultados en el Congreso de Wonca Europa (Organización Europea de la Wonca).

Los resultados finales del proyecto se publicarán en un artículo de acceso abierto de alto impacto. La publicación buscará un ranking Q1, garantizando amplia accesibilidad y visibilidad de los hallazgos.

Memoria económica y fuente de financiación

Subtotal sin presupuesto de contingencia: 72.995 €
Subtotal con presupuesto de contingencia: 76.644,75 €

Desglose:

- **Recursos para el plan de comunicación** - subtotal 2.000 €
  - Cartelería y material de papelería: 2.000 €

- **Creación y mantenimiento de web** - subtotal 1.315 €
  - **Diseño de página web**: 0 € (a cargo de personal técnico)
  - **Plugins**: 400 €
  - **Protección de datos**: 500 €
  - **Dominio**: 15 €/año aprox.
  - **Hosting**: 400 €/año.
  - **Mantenimiento web**: 0 € (a cargo de personal técnico)

- **Recursos humanos** - subtotal 61.600 €:
  Todos a coste de empresa y según la tabla salarial del IIS Galicia Sur
  - Personal a media jornada para la puesta en marcha de la plataforma, elaboración de contenido y gestión de redes sociales: 15.600 €
  - Personal a media jornada para la elaboración del estudio previo, evaluación continua y adaptabilidad así como la evaluación final del impacto y resultados del proyecto: 15.600 €
  - Personal con formación médica dedicadas a formación y revisión de contenidos (jornada equivalente al 30% anual de un facultativo para intensificaciones parciales): 20.000 €
  - Personal informático (contratación o subcontratación) dedicado a la implementación del sistema y la programación de toda la implantación 4 meses: 10.400€

- **Implementación del sistema** - subtotal 8.080 €
  - Mantenimiento: 3.240 €

- Alquiler: 1.440€ /año
- Base de de datos: 1.600€ /año
- Mantenimiento técnico: 1.800€ /año

- **Reserva de contingencia del 5 % de presupuesto total:** 3.649,75 €

El proyecto dispone de financiación específica que asciende a 45.000 € obtenidos a través de sendos convenios entre AbbVie y Novo Nordisk con la Fundación Biomédica Galicia Sur, cifra que incluye los correspondientes overheads.

Bibliografía

- Ayers, J. W., Poliak, A., Dredze, M., Leas, E. C., Zhu, Z., Kelley, J. B., Faix, D. J., Goodman, A. M., Longhurst, C. A., Hogarth, M., & Smith, D. M. (2023). Comparing Physician and Artificial Intelligence Chatbot Responses to Patient Questions Posted to a Public Social Media Forum. *JAMA internal medicine*, e231838. Advance online publication. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2023.1838
- Cernadas Ramos, A., Bouzas-Lorenzo, R., Mesa Del Olmo, A., & Barral Buceta, B. (2020). Opinión de los facultativos y usuarios sobre avances de la e-salud enAtención Primaria [Opinion of doctors and users on e-health advances in primary care].Atención Primaria, 52(6), 389–399. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2019.05.008
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Padrón Municipal de Pontevedra [Datos del año 2022]. Recuperado el 3 de julio de 2023, de https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2890

- Mitchell, G. K., Brown, R. M., Erikssen, L., & Tieman, J. J. (2008). Multidisciplinary care planning in the primary care management of completed stroke: A systematic review. BMC Family Practice, 9(1), 44. https://doi.org/10.1186/1471-2296-9-44
- Organización Mundial de la Salud. (2020). Global strategy on digital health 2020-2025. Recuperado el 22 de marzo de 2023, de https://www.who.int/publications/i/item/9789240016780
- Secretaría General de Información e Innovación para el SNS Información e Innovación para el SNS Salud Digital,. (2021). ESTRATEGIA DE SALUD DIGITAL. SISTEMA NACIONAL DE SALUD. https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pdf/Estrategia_de_Salud_Digital_del_SNS.pdf
- Tian, P. G. J., Harris, J. R., Seikaly, H., Chambers, T., Alvarado, S., & Eurich, D. (2021). Characteristics and Outcomes of Physician-to-Physician Telephone Consultation Programs: Environmental Scan. JMIR formative research, 5(2), e17672. https://doi.org/10.2196/17672
- Urruticoechea-Arana, A., León-Vázquez, F., Giner-Ruiz, V., Andréu-Sánchez, J. L., Olivé-Marqués, A., Freire-González, M., ... & Rúa-Figueroa, Í. (2020). Desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles (app) basada en la colaboración Sociedad Española de Reumatología/Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria para derivación de enfermedades autoinmunes sistémicas. Reumatología Clínica, 16(5), 373-377.
- Vicepresidencia Tercera del Gobierno. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (2020). España Digital 2025

ANEXOS

ANEXO 1: Cuestionario

COORDINACIÓN AP-AH

Los médicos de Atención Primaria y especializada compartimos información sobre la atención de los pacientes que atendemos en común (diagnóstico, pruebas complementarias, tratamientos)
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca No sé No respondo

Los médicos de Atención Primaria y especializada llevamos a la práctica clínica la información que compartimos en charlas, e-consultas…
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca No sé No respondo

Los médicos de Atención Primaria y especializada definimos conjuntamente el plan de atención de los pacientes que lo requieren
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca No sé No respondo

Los médicos de atención especializada hacen recomendaciones al médico de Atención Primaria sobre el seguimiento de los pacientes (diagnóstico, tratamiento, otras orientaciones)
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca No sé No respondo

Los médicos de Atención Primaria consultan las dudas sobre el seguimiento de los pacientes a los médicos de la atención especializada
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca No sé No respondo

Creo que la atención entre los médicos de Atención Primaria y especializada está coordinada
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca No sé No respondo

La coordinación entre los niveles asistenciales ha mejorado gracias a COMTA

SATISFACCIÓN CON COMTA

¿De los siguientes mecanismos cuál es el que más utiliza para la coordinación con el Servicio de Digestivo?
-Correo electrónico
-Teléfono
-E-Consultas
-Sesiones clínicas
-COMTA

¿Con qué frecuencia utiliza el nuevo sistema COMTA?
Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca

Lo que más me gusta de COMTA es:
-La rapidez de la respuesta
-La información que me proporciona es del equipo de Digestivo de Pontevedra
-Me ahorra tiempo en la consulta
-Es muy sencilla de utilizar
-Mejora de la atención al paciente.
-Otros:

Lo que menos me gusta de COMTA es:
- Tarda en responder
- No ofrece respuestas de calidad, tiene errores
- Hay que dedicar mucho tiempo para llegar a la respuesta
- Es difícil de utilizar

Muestre su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
-Recurro a COMTA siempre que tengo dudas sobre Digestivo
Estoy completamente de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
No estoy ni deacuerdo ni en desacuerdo
Estoy en desacuerdo.
Estoy completamente en desacuerdo.

-Considero que sistema COMTA es útil
Estoy completamente de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
No estoy ni deacuerdo ni en desacuerdo
Estoy en desacuerdo.
Estoy completamente en desacuerdo.

-Prefiero utilizar COMTA que otras herramientas de consulta de información
Estoy completamente de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
No estoy ni deacuerdo ni en desacuerdo
Estoy en desacuerdo.
Estoy completamente en desacuerdo.

-COMTA mejora la coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria
Estoy completamente de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
No estoy ni deacuerdo ni en desacuerdo
Estoy en desacuerdo.

Estoy completamente en desacuerdo.

-El uso de COMTA permite optimizar el tiempo de mis consultas
Estoy completamente de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
No estoy ni deacuerdo ni en desacuerdo
Estoy en desacuerdo.
Estoy completamente en desacuerdo.

-El uso de COMTA mejora la atención del paciente
Estoy completamente de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
No estoy ni deacuerdo ni en desacuerdo
Estoy en desacuerdo.
Estoy completamente en desacuerdo.

-Considero que mediante el uso de COMTA es más rápido llegar al diagnóstico
Estoy completamente de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
No estoy ni deacuerdo ni en desacuerdo
Estoy en desacuerdo.
Estoy completamente en desacuerdo.

-Me gustaría utilizar COMTA en otras especialidades
Estoy completamente de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
No estoy ni deacuerdo ni en desacuerdo
Estoy en desacuerdo.
Estoy completamente en desacuerdo.